UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MÉCANICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS



Plan de Tesis

"SISTEMA BIDIRECCIONAL DE TRADUCCIÓN DE VOZ QUECHUA–ESPAÑOL CON IA PREENTRENADA PARA CONSULTAS MÉDICAS EN CUSCO"

Para optar al título profesional de:
INGENIERO INFORMÁTICO Y DE SISTEMAS

Presentado por:
Alain Armando Condori Contreras

Código de alumno:
021501

Asesor:
Mtro. Ing. Raúl Huillca Huallparimachi

Perú, Octubre de 2026

Resumen

En la región Cusco, más del 55 % de la población tiene el quechua como lengua materna y cerca de 70 000 asegurados de EsSalud son quechuahablantes (EsSalud, 2023); esta barrera idiomática afecta la calidad de la atención en salud (Begazo Solís, 2026). El presente trabajo propone desarrollar y evaluar un sistema bidireccional de traducción de voz Quechua–Español para consultas médicas, que encadena reconocimiento de voz (MMS), traducción automática (NLLB adaptado al quechua de Cusco, `quz`) y síntesis de voz (MMS-TTS) mediante el ajuste (*fine-tuning*) de modelos preentrenados de código abierto. La salida por voz en ambos sentidos busca incluir a la población quechuahablante con baja o nula alfabetización. La validación se realizará con consultas simuladas, sin datos reales de pacientes, midiendo precisión (WER, BLEU, chrF), calidad de voz (MOS) y percepción de utilidad. Se espera aportar el primer corpus clínico Quechua–Español y evidencia empírica sobre la viabilidad de estas tecnologías en el dominio sanitario andino.

Palabras clave: traducción automática, quechua, PLN, inclusión digital, comunicación médico-paciente, ASR, TTS.

Índice general

Resumen **1**

Índice de figuras **5**

Índice de cuadros **6**

Índice de algoritmos **7**

Índice de símbolos **8**

Índice de abreviaturas **9**

Índice de ecuaciones **10**

Glosario de términos **11**

I Introducción **12**

1.1 Contexto y problema general 12
1.2 Tecnología o método 13
1.3 Vacío de investigación 13
1.4 Problema específico 13
1.4.1 Problema general 14
1.4.2 Problemas específicos 14
1.5 Propuesta, objetivo y justificación 14
1.5.1 Propuesta 14
1.5.2 Objetivo general 14
1.5.3 Objetivos específicos 14
1.5.4 Hipótesis 15
1.5.5 Justificación 15
1.5.6 Alcances y limitaciones 16
1.6 Organización de la tesis 16

II Marco teórico y estado del arte **16**

2.1 Antecedentes 16
2.1.1 Antecedentes internacionales 17
2.1.2 Antecedentes nacionales 17
2.1.3 Antecedentes locales 17
2.2 Estado del arte y brecha de investigación 18
2.3 Fundamentos teóricos 18
2.3.1 Tecnologías del habla y traducción automática neuronal 18

2.3.2 Modelos multilingües preentrenados (MMS, NLLB, Whisper) . . 19
2.3.3 Ajuste fino y adaptación dialectal (quy→quz) 19
2.3.4 Arquitectura en cascada ASR→MT→TTS 19
2.3.5 Métricas de evaluación 19
2.4 Definición de términos básicos 19

III Metodología de la investigación **20**
3.1 Enfoque, tipo y diseño de investigación 20
3.1.1 Enfoque de investigación 20
3.1.2 Tipo de investigación 20
3.1.3 Diseño de investigación 20
3.2 Variables y operacionalización 21
3.2.1 Identificación de variables 21
3.2.2 Matriz de operacionalización de variables 21
3.3 Unidades de análisis y selección de consultas 21
3.3.1 Unidad de análisis 21
3.3.2 Población y muestra 21
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección 21
3.5 Procedimiento metodológico 22
3.6 Protocolo de evaluación 22
3.6.1 Métricas de reconocimiento y traducción 22
3.6.2 Métricas de calidad de voz y comprensión 22
3.6.3 Métricas de eficiencia 23
3.7 Métodos de análisis de datos 23
3.8 Aspectos éticos y de gestión de datos 23

IV Estudio de factibilidad **23**
4.1 Enfoque adoptado 23
4.2 Factibilidad técnica 23
4.2.1 Hardware, cómputo e inferencia 23
4.2.2 Estrategia de datos 23
4.2.3 Herramientas y software 24
4.3 Factibilidad económica 24
4.4 Factibilidad operativa 24
4.5 Viabilidad y sostenibilidad 24

V Aspectos administrativos **24**
5.1 Cronograma de actividades 24
5.2 Presupuesto y financiamiento 25
5.3 Equipo de investigación 25

Referencias **27**

Anexos **31**

Anexo 1: Matriz de consistencia lógica 31
Anexo 2: Matriz de consistencia metodológica 31
Anexo 3: Ficha técnica de registro experimental 32
Anexo 4: Plantilla del banco de frases de consulta (evaluación) 32
Anexo 5: Cuestionario de percepción (escala Likert) 33
Anexo 6: Modelo de consentimiento informado 33

Índice de figuras

1 Magnitud de la problemática en Cusco. Elaboración propia con datos de EsSalud (2023) e Instituto Nacional de Estadística e Informática (2023). 13
2 Pipeline modular **bidireccional** por voz; la traducción NLLB adaptada al quechua de Cusco (`quz`) es el núcleo del aporte. Elaboración propia. 20

Índice de tablas

1 Síntesis del estado del arte por componente (elaboración propia). 18
2 Operacionalización de variables. 21
3 Cronograma de actividades (octubre 2026 – enero 2027), por semanas. . 25
4 Recursos para el desarrollo del proyecto de tesis (soles). 25
5 Equipo de investigación. 26
6 Matriz de consistencia lógica. 31
7 Matriz de consistencia metodológica. 32
8 Ficha técnica de registro por turno (plantilla). 32
9 Banco de frases de consulta simulada (ejemplos; `quz` por validar). . . . 33
10 Ítems del cuestionario de percepción. 33

Índice de algoritmos

1 Traducción bidireccional por voz de un turno de diálogo 20

Índice de símbolos

Símbolo	Descripción	Unidad
α	Nivel de significancia estadística	—
p	Valor de probabilidad (p-valor)	—
N	Tamaño de muestra / n. de palabras de referencia	—
β	Factor de ponderación recall/precisión en chrF	—

Índice de abreviaturas

Sigla	Significado
IA	Inteligencia artificial
PLN	Procesamiento del lenguaje natural
ASR	Reconocimiento automático del habla (*Automatic Speech Recognition*)
STT	Voz a texto (*Speech-to-Text*)
TTS	Síntesis de voz (*Text-to-Speech*)
MT	Traducción automática (*Machine Translation*)
NMT	Traducción automática neuronal
MMS	*Massively Multilingual Speech* (Meta)
NLLB	*No Language Left Behind* (Meta)
WER	Tasa de error de palabra (*Word Error Rate*)
BLEU	*Bilingual Evaluation Understudy*
chrF	*Character n-gram F-score*
MOS	*Mean Opinion Score*
quz	Quechua Collao / Cusco (código ISO 639-3)
quy	Quechua Ayacucho (código ISO 639-3)
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática
EsSalud	Seguro Social de Salud del Perú
UNSAAC	Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Índice de ecuaciones

1 Tasa de error de palabra (WER) 22
2 Puntaje chrF (F-score de n-gramas de caracteres) 22

Glosario de términos

Término	Definición
Corpus	Conjunto estructurado de textos o grabaciones usado para entrenar o evaluar modelos.
Fine-tuning	Ajuste de un modelo preentrenado con datos de un dominio específico.
Lengua de bajo recurso	Idioma con escasez de datos digitales para entrenar modelos de PLN.
Modelo preentrenado	Modelo entrenado sobre grandes volúmenes de datos, reutilizable mediante ajuste.
Lengua polisintética	Lengua que concentra mucha información gramatical en una sola palabra, como el quechua.
Pipeline	Secuencia encadenada de etapas (voz → texto → traducción → voz).

I Introducción

La introducción de este plan sigue el *sistema de seis bloques*: parte del contexto y el problema general, presenta la tecnología disponible, identifica el vacío de investigación, precisa el problema específico, formula la propuesta con sus objetivos, hipótesis y justificación, y cierra con la organización del documento.

1.1 Contexto y problema general

El Perú es un país plurilingüe en el que el quechua es la lengua originaria con mayor número de hablantes. Los Censos Nacionales 2017 registran a millones de peruanos que declaran el quechua como lengua materna, con una marcada concentración en la sierra sur (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017). En la región Cusco esta presencia es particularmente intensa: más del 55 % de la población tiene el quechua como lengua materna (EsSalud, 2023). Esta realidad lingüística condiciona el acceso efectivo a los servicios públicos esenciales —la atención en salud entre ellos— cuando operan de manera predominante en español.

En el ámbito sanitario, la distancia idiomática entre un personal de salud mayoritariamente castellanohablante y una población usuaria quechuahablante origina una barrera comunicativa con consecuencias clínicas directas. EsSalud reconoce que cerca de 70 000 de sus asegurados en Cusco son quechuahablantes y reactivó en 2023 la central telefónica en quechua (EsSalud, 2023); sin embargo, esa medida no alcanza la interacción cara a cara del consultorio, donde se recogen síntomas, se formula el diagnóstico y se entregan las indicaciones. La evidencia confirma la gravedad del problema: Begazo Solís (2026) documenta cómo la desconexión idiomática vulnera la relación terapéutica en hospitales de Cusco, y Cuaila (2022) halla una relación entre el conocimiento del quechua del personal y la calidad de atención percibida. A ello se suma una barrera de alfabetización: cerca del 22.8 % de las mujeres rurales no sabe leer ni escribir (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2023), lo que obliga a una solución basada en *voz* y no solo en texto (Figura 1).

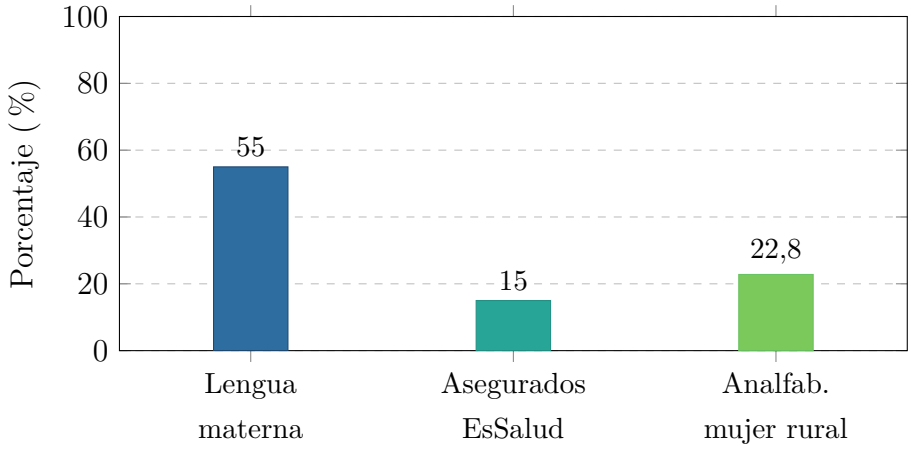


Figura 1: Magnitud de la problemática en Cusco. Elaboración propia con datos de EsSalud (2023) e Instituto Nacional de Estadística e Informática (2023).

1.2 Tecnología o método

El estado del arte en procesamiento del lenguaje natural ofrece hoy una oportunidad que no existía hace pocos años. La estrategia dominante para lenguas de bajo recurso ya no consiste en entrenar modelos desde cero, sino en adaptar (*fine-tuning*) grandes modelos multilingües preentrenados. En la voz, el proyecto MMS (Pratap et al., 2024) cubre el quechua de Cusco (`quz`) en reconocimiento y síntesis; Whisper (Radford et al., 2023) declara una cobertura marginal del quechua y se reserva como línea base. En traducción, NLLB (NLLB Team, 2022) incluye el quechua de Ayacucho (`quy`) y no el de Cusco, por lo que el par debe adaptarse a `quz` —esa brecha dialectal es el núcleo del aporte técnico—. Existen además antecedentes de traducción neural para esta lengua polisintética (Mager et al., 2021; Ortega et al., 2020) y recursos como el corpus *Huqariq* (Zevallos, Camacho & Melgarejo, 2022).

1.3 Vacío de investigación

Persiste una desconexión entre ambos mundos: el problema social está bien documentado y la tecnología base existe, pero nadie ha unido los dos extremos. No se dispone de un corpus clínico Quechua–Español ni de una evaluación empírica del desempeño de estos modelos sobre el vocabulario propio de la consulta médica (triaje, síntomas e indicaciones), y NLLB aún no cubre la variante de Cusco (`quz`). Cerrar esa intersección es el aporte de este proyecto.

1.4 Problema específico

El problema específico de esta investigación se concentra en la comunicación médico-paciente mediada por un sistema bidireccional de traducción de voz Quechua–Español

basado en modelos preentrenados, y en la medida en que su ajuste al dominio clínico mejora la precisión y la comprensión frente a la ausencia de apoyo tecnológico.

1.4.1. Problema general

¿De qué manera un sistema bidireccional de traducción de voz Quechua–Español, basado en modelos de IA preentrenados, influye en la comunicación entre el personal de salud y los pacientes quechuahablantes durante las consultas médicas en Cusco?

1.4.2. Problemas específicos

1. ¿Qué características debe reunir un corpus de vocabulario clínico Quechua–Español para el ajuste de los modelos de traducción por voz?

2. ¿En qué medida el ajuste (*fine-tuning*) de modelos preentrenados mejora la precisión sobre el vocabulario clínico?

3. ¿Qué modalidad de salida (texto para el personal; texto y voz para el paciente) resulta más confiable y comprensible?

4. ¿Qué nivel de utilidad, confianza y comprensión perciben el personal y los pacientes al usar el sistema en consultas simuladas?

1.5 Propuesta, objetivo y justificación

1.5.1. Propuesta

Se propone desarrollar y evaluar un sistema bidireccional de traducción de voz Quechua–Español para consultas médicas, que encadena reconocimiento de voz (MMS), traducción automática (NLLB adaptado de `quy` a `quz`) y síntesis de voz (MMS-TTS) mediante el ajuste de modelos preentrenados de código abierto, con salida por voz en ambos sentidos del diálogo.

1.5.2. Objetivo general

Desarrollar y evaluar un sistema bidireccional de traducción de voz Quechua–Español, basado en modelos de IA preentrenados, para mejorar la comunicación médico-paciente durante las consultas médicas en Cusco.

1.5.3. Objetivos específicos

1. Construir y validar un corpus de vocabulario y frases de consulta médica en Quechua–Español.

2. Adaptar (*fine-tuning*) los modelos preentrenados de voz (MMS) y, como aporte central, el modelo de traducción NLLB del quechua de Ayacucho (`quy`) al de Cusco (`quz`) sobre el dominio clínico.

3. Integrar el *pipeline* bidireccional con salida por voz y texto para ambos interlocutores, utilizable por pacientes con baja o nula alfabetización.

4. Validar el sistema en consultas simuladas, midiendo precisión, calidad de voz, tiempo y percepción.

1.5.4. Hipótesis

General: un sistema bidireccional de traducción de voz Quechua–Español, basado en modelos de IA preentrenados, mejora significativamente la comunicación médico-paciente durante las consultas médicas en Cusco frente a la ausencia de apoyo tecnológico.

- **H1:** un corpus clínico Quechua–Español validado proporciona la base léxica necesaria para el ajuste de los modelos.
- **H2:** el ajuste (*fine-tuning*) de los modelos preentrenados reduce el WER y mejora el BLEU/chrF frente a los modelos sin ajustar.
- **H3:** la salida texto+voz mejora la comprensión de las indicaciones frente a solo texto, sobre todo con baja alfabetización.
- **H4:** el uso del sistema mejora significativamente la comprensión mutua percibida frente a la ausencia de apoyo tecnológico.

1.5.5. Justificación

Teórica: aporta evidencia empírica del desempeño de modelos preentrenados en una lengua de bajo recurso y morfología compleja. **Práctica:** entrega un prototipo piloteable en un centro de salud. **Social:** ataca una inequidad documentada en el acceso a la salud (Begazo Solís, 2026), en línea con el derecho de los pacientes a ser atendidos en su lengua materna (EsSalud, 2023). **Metodológica:** establece un proceso replicable (corpus + ajuste + evaluación) en otras variantes del quechua o en otros dominios. Entre las contribuciones originales esperadas destacan el **primer corpus de dominio médico** Quechua–Español para tecnologías del habla, la **adaptación de NLLB de `quy` a `quz`** en el dominio clínico (aporte técnico central) y un **sistema integrado ASR+MT+TTS** con salida por voz para usuarios con baja alfabetización. En conjunto, el proyecto contribuye a la equidad en el acceso a la salud de la población quechuahablante de Cusco, a la seguridad del acto médico y a la revitalización y el prestigio digital del quechua.

1.5.6. Alcances y limitaciones

Alcances.

- Par lingüístico Quechua de Cusco (`quz`) – Español, en ambos sentidos.
- Vocabulario acotado de consulta general (triaje, síntomas, indicaciones).
- Prototipo integrado ASR+MT+TTS con salida por voz y texto.
- Validación con consultas simuladas en un centro de salud de referencia en Cusco.

Limitaciones.

- **Temporal:** ejecución entre octubre 2026 y enero 2027.
- **Ética:** se emplean diálogos simulados/actuados, sin datos reales de pacientes.
- Desempeño condicionado por la escasez de datos de dominio clínico en quechua.
- Resultados circunscritos a la variante de Cusco; no generalizables sin ajuste a otras variantes.

1.6 Organización de la tesis

El documento se organiza en cinco capítulos. El **Capítulo I** presenta la introducción —contexto, tecnología, vacío, problema, propuesta, objetivos, hipótesis y justificación— . El **Capítulo II** desarrolla el marco teórico y el estado del arte derivado de la revisión sistemática. El **Capítulo III** detalla la metodología: enfoque, diseño, variables, unidades de análisis, técnicas, procedimiento, protocolo de evaluación y aspectos éticos. El **Capítulo IV** analiza la factibilidad técnica, económica y operativa. El **Capítulo V** expone los aspectos administrativos —cronograma, presupuesto y equipo—. Finalmente, la **matriz de consistencia** articula el problema, los objetivos, las hipótesis y las variables.

II Marco teórico y estado del arte

2.1 Antecedentes

Los trabajos previos sobre tecnologías del habla y traducción automática para el quechua se organizan en tres niveles —internacional, nacional y local—. En conjunto evidencian avances sólidos por componente (ASR, MT y TTS), pero ninguno aborda su integración en el dominio médico-paciente ni la variante de Cusco (`quz`).

2.1.1. Antecedentes internacionales

La traducción neural para el quechua fue abordada por primera vez por Ortega et al. (2020), que introdujo técnicas de segmentación morfológica para esta lengua polisintética. Las competencias AmericasNLP impulsaron el área: Gow-Smith y Sánchez Villegas (2023) extendieron NLLB-200 con una mejora promedio de 11 % en chrF, mientras que Ahmed et al. (2023) y Dhawan et al. (2026) exploraron modelos preentrenados y datos sintéticos (Ebrahimi et al., 2024). En el habla, C.-C. Chen et al. (2024) evaluaron representaciones autosupervisadas para lenguas indígenas y W. Chen y Fazio (2021) propusieron una segmentación guiada por la morfología. La serie *QUESPA* en IWSLT llevó la traducción de voz Quechua–Español de cerca de 16 a **26.7 BLEU** entre 2023 y 2025 (Ortega et al., 2023, 2024, 2025). Estos avances se apoyan en grandes modelos multilingües preentrenados —MMS (Pratap et al., 2024), NLLB (NLLB Team, 2022) y Whisper (Radford et al., 2023)—.

2.1.2. Antecedentes nacionales

En el Perú, Zevallos et al. (2020) implementaron un ASR de quechua con HMM/HTK alcanzando **12.70 % de WER**, mejorado luego mediante aumento de datos hasta 22.75 % de WER (Zevallos, Bel et al., 2022); el mismo grupo aportó el modelo *QuBERT* (Zevallos, Ortega et al., 2022) y el corpus *Huqariq* (Zevallos, Camacho & Melgarejo, 2022). En síntesis de voz, Huamán Curo y Pineda Ancco (2026) evaluaron cuatro arquitecturas TTS para el quechua chanca con un MOS de hasta **4.9**. En traducción, Barbaran y Ticona (2026) (UTP) y Cueva Medina et al. (2024) (UCSM, Arequipa) ajustaron modelos neuronales Quechua–Español, y Moreno Véliz (2021) (PUCP) y Oncevay (2021) trabajaron enfoques multilingües para las lenguas del Perú. En traducción de voz, Alvarez-Crespo et al. (2023) (UPC) desarrollaron un subtitulado en tiempo real Español→Quechua con arquitectura en cascada, y Guzman et al. (2021) construyeron una plataforma para recolectar un corpus de voz Español/Quechua mediante la API *Siminchikkunarayku*. Ninguno de estos trabajos abordó el dominio sanitario.

2.1.3. Antecedentes locales

En Cusco, la evidencia se concentra en el problema más que en la solución: Begazo Solís (2026) documentó cómo la barrera idiomática vulnera la relación terapéutica en hospitales de referencia de la ciudad, y EsSalud reactivó en 2023 una central telefónica en quechua para sus asegurados cusqueños (EsSalud, 2023); en una región andina vecina, Cuaila (2022) asoció el dominio del quechua del personal con la calidad de atención percibida. En el plano tecnológico, el primer sistema de traducción neural para el quechua se desarrolló con participación de *Hinantin Software* de Cusco (Ortega et al., 2020), y la variante Collao/Cusco (`quz`) fue incorporada recién en la campaña

QUESPA 2025 (Ortega et al., 2025). A ello se suma el reto de la alfabetización en zonas rurales andinas (Fundación Dispurse, 2023; Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2023). No se identificó ningún antecedente local que integre reconocimiento, traducción y síntesis de voz para la atención en salud, lo que confirma la pertinencia de esta investigación.

2.2 Estado del arte y brecha de investigación

A partir de una **revisión sistemática** (Scopus, IEEE Xplore y ACM Digital Library; 62 registros identificados, 58 tras depurar duplicados y 30 evaluados a texto completo), los antecedentes de la sección anterior se sintetizan por componente en el Cuadro 1 —sin repetir las citas ya detalladas—, lo que permite ubicar con precisión qué se ha resuelto y qué sigue abierto.

Tabla 1: Síntesis del estado del arte por componente (elaboración propia).

Componente	**Avance / mejor resultado reportado**	**¿Salud?**
ASR (quechua)	WER 12.70 % (HMM/HTK) y 22.75 % con aumento de datos	No
MT (QU–ES)	Hasta +11 % chrF; BLEU 15.47 con modelos ajustados	No
TTS (quechua)	MOS de hasta 4.9 (XTTS v2)	No
Traducción de voz (cascada)	26.7 BLEU (QUESPA 2025, variante Collao)	No
Recursos / corpus	QuBERT, *Huqariq*, API *Siminchikkunarayku*	Habilitador

La síntesis evidencia avances sólidos por componente, pero ninguno en el **dominio clínico** ni con la variante de Cusco (`quz`) integrada de extremo a extremo. La **brecha** es, por tanto, la intersección —hoy vacía— entre las tecnologías del habla para el quechua y la comunicación médico-paciente: no existe un corpus clínico Quechua–Español ni una evaluación empírica de estos modelos en salud, y NLLB aún no cubre `quz`. Cerrar esa intersección es el aporte de este proyecto.

2.3 Fundamentos teóricos

2.3.1. Tecnologías del habla y traducción automática neuronal

El **reconocimiento automático de voz (ASR)** convierte una señal de voz en texto; la **traducción automática (MT)**, hoy mayoritariamente *neuronal* con arquitecturas Transformer, traduce entre idiomas; y la **síntesis de voz (TTS)** genera voz a partir de texto. En **lenguas de bajo recurso** —como el quechua, de morfología

polisintética— estas tareas se benefician de la transferencia desde modelos entrenados sobre grandes volúmenes de datos multilingües.

2.3.2. Modelos multilingües preentrenados (MMS, NLLB, Whisper)

MMS (Pratap et al., 2024) cubre el quechua de Cusco (`quz`) en reconocimiento y síntesis; **NLLB** (NLLB Team, 2022) ofrece traducción multilingüe que incluye el quechua de Ayacucho (`quy`); y **Whisper** (Radford et al., 2023) se emplea como referencia de ASR con cobertura marginal del quechua. Estos modelos permiten reutilizar conocimiento lingüístico general y especializarlo mediante ajuste.

2.3.3. Ajuste fino y adaptación dialectal (`quy`→`quz`)

El *ajuste fino* (*fine-tuning*) adapta un modelo preentrenado a un dominio o variante específicos con relativamente pocos datos. El aporte técnico central de esta tesis es la adaptación del par de traducción del quechua de Ayacucho (`quy`) al de Cusco (`quz`) sobre el vocabulario clínico, cerrando la brecha dialectal que hoy limita a NLLB.

2.3.4. Arquitectura en cascada ASR→MT→TTS

El encadenamiento de los tres componentes en una **arquitectura en cascada** habilita un diálogo bidireccional por voz: la voz del hablante se transcribe (ASR), el texto se traduce (MT) y la traducción se reproduce en la lengua del interlocutor (TTS). La modularidad facilita ajustar y evaluar cada etapa por separado.

2.3.5. Métricas de evaluación

El desempeño se mide con métricas estandarizadas: **WER** para el reconocimiento, **BLEU** (Papineni et al., 2002) y **chrF** (Popović, 2015) para la traducción —esta última adecuada para lenguas morfológicamente ricas— y **MOS** para la naturalidad de la voz sintetizada. Su formulación operativa se detalla en el Capítulo III.

2.4 Definición de términos básicos

- **Corpus:** conjunto estructurado de textos o grabaciones para entrenar o evaluar modelos.
- **Modelo preentrenado:** modelo entrenado sobre grandes volúmenes de datos, reutilizable mediante ajuste.
- **Lengua de bajo recurso:** idioma con escasez de datos digitales para el PLN.
- **Lengua polisintética:** lengua que concentra mucha información gramatical en una sola palabra, como el quechua.

- **Pipeline:** secuencia encadenada de etapas (voz → texto → traducción → voz).

III Metodología de la investigación

3.1 Enfoque, tipo y diseño de investigación

3.1.1. Enfoque de investigación

La investigación adopta un enfoque **cuantitativo con complemento cualitativo** (mixto): las métricas de desempeño (WER, BLEU, chrF, MOS, latencia) aportan la evidencia cuantitativa, y la percepción de utilidad y comprensión aporta el complemento cualitativo.

3.1.2. Tipo de investigación

Es de tipo **aplicado** —resuelve un problema concreto mediante un prototipo— y de nivel **explicativo**, pues contrasta el efecto del sistema frente a la ausencia de apoyo tecnológico.

3.1.3. Diseño de investigación

El diseño es **pre-experimental / cuasi-experimental**; la unidad de análisis es el *turno de traducción* dentro de una consulta simulada. La Figura 2 muestra el flujo del sistema y el Algoritmo 1 detalla el procesamiento de un turno de diálogo.

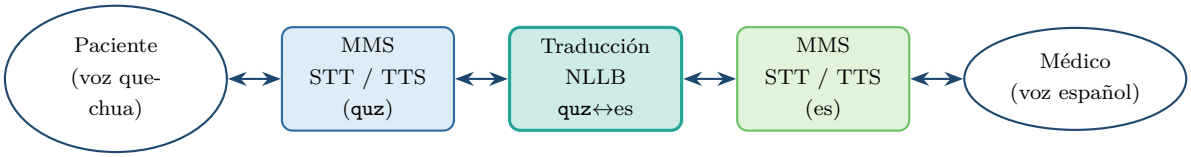


Figura 2: Pipeline modular **bidireccional** por voz; la traducción NLLB adaptada al quechua de Cusco (`quz`) es el núcleo del aporte. Elaboración propia.

Algoritmo 1 Traducción bidireccional por voz de un turno de diálogo

Require: Audio de entrada a; idioma origen L_s; idioma destino L_t

Ensure: Texto traducido t_t y audio sintetizado a_t

1: $t_s \leftarrow \mathrm{STT}_{\mathrm{MMS}}(a,\, L_s)$
2: $t_t \leftarrow \mathrm{MT}_{\mathrm{NLLB}}(t_s,\, L_s \rightarrow L_t)$
3: Mostrar t_t en pantalla
4: $a_t \leftarrow \mathrm{TTS}_{\mathrm{MMS}}(t_t,\, L_t)$
5: Reproducir a_t
6: **return** $(t_t,\, a_t)$

3.2 Variables y operacionalización

3.2.1. Identificación de variables

La **variable independiente** es el uso del sistema de traducción (con/sin sistema) y la modalidad de salida (texto / texto+voz). Las **variables dependientes** son la precisión de transcripción y traducción, la calidad de la voz y la comprensión/percepción. El nivel de alfabetización actúa como **variable interviniente**.

3.2.2. Matriz de operacionalización de variables

El Cuadro 2 resume la operacionalización.

Tabla 2: Operacionalización de variables.

Variable	Definición / dimensión	Indicador
Independiente	Uso del sistema de traducción IA	Con / sin sistema
	Modalidad de salida	Texto / texto+voz
Dependiente	Precisión de transcripción	WER
	Precisión de traducción	BLEU / chrF
	Comprensión y percepción	% aciertos, Likert, MOS
Interviniente	Nivel de alfabetización	Alto / bajo

3.3 Unidades de análisis y selección de consultas

3.3.1. Unidad de análisis

La unidad de análisis es el *turno de traducción* dentro de una consulta simulada (una intervención hablada que el sistema reconoce, traduce y reproduce). Los escenarios cubren triaje, síntomas e indicaciones.

3.3.2. Población y muestra

Participantes voluntarios (estudiantes de ciencias de la salud y/o personal asistencial bilingüe) que actúan roles en consultas simuladas; *no* se usan pacientes ni datos clínicos reales. Muestreo no probabilístico por conveniencia (10–15 participantes; 30–50 frases-guión por escenario).

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección

- **Corpus:** lista de vocabulario y frases de triaje/síntomas/indicaciones, construida y revisada con personal de salud (fichas de validación de contenido).

- **Registro de desempeño:** *logs* automáticos del sistema (WER, BLEU, latencia por turno).
- **Encuesta de percepción:** cuestionario tipo Likert (utilidad, confianza, comprensión) al personal y a los pacientes-actores.
- **Prueba de comprensión:** tarea de recuperación de la indicación (% de aciertos) para contrastar H2 y H3.

3.5 Procedimiento metodológico

1. Construcción y validación del corpus médico Quechua–Español.
2. Ajuste (*fine-tuning*) de MMS (reconocimiento y síntesis) y, como aporte central, de NLLB para el par quechua de Cusco (`quz`)–Español.
3. Integración del *pipeline* y de la salida diferenciada por voz y texto.
4. Ejecución de consultas simuladas bajo las condiciones experimentales.
5. Registro de métricas y aplicación de instrumentos de percepción.

3.6 Protocolo de evaluación

3.6.1. Métricas de reconocimiento y traducción

La precisión del reconocimiento se mide con la tasa de error de palabra (WER):

$$\mathrm{WER} = \frac{S + D + I}{N}, \tag{1}$$

donde S, D e I son sustituciones, eliminaciones e inserciones sobre N palabras de referencia. La traducción se evalúa con BLEU (Papineni et al., 2002) y chrF (Popović, 2015); esta última, adecuada para lenguas morfológicamente ricas:

$$\mathrm{chrF}_\beta = (1 + \beta^2)\,\frac{\mathrm{chrP} \cdot \mathrm{chrR}}{\beta^2\,\mathrm{chrP} + \mathrm{chrR}}. \tag{2}$$

3.6.2. Métricas de calidad de voz y comprensión

La calidad de la voz sintetizada se valora con el *Mean Opinion Score* (MOS). La comprensión se mide con el porcentaje de aciertos en la recuperación de la indicación y con escalas Likert de utilidad y confianza.

3.6.3. Métricas de eficiencia

La eficiencia se cuantifica con la *latencia por turno* (tiempo entre el fin de la voz de entrada y el inicio de la voz de salida) y el consumo de recursos de cómputo.

3.7 Métodos de análisis de datos

Estadística descriptiva para WER/BLEU/MOS/latencia y pruebas de comparación de medias/proporciones (t de Student o Wilcoxon según normalidad), con un nivel de significancia $\alpha = 0{,}05$, para contrastar las hipótesis (modelo ajustado vs. sin ajustar; texto vs. texto+voz).

3.8 Aspectos éticos y de gestión de datos

El estudio usa únicamente diálogos **simulados/actuados**, sin información clínica real, evitando la necesidad de aprobación de un comité de ética hospitalario para datos de pacientes. Se obtiene consentimiento informado de los participantes voluntarios y se anonimizan las grabaciones, en cumplimiento del atributo de ética del curso. Los datos se almacenan de forma segura y se usan solo con fines de investigación.

IV Estudio de factibilidad

4.1 Enfoque adoptado

El proyecto es viable porque reutiliza modelos preentrenados de código abierto (MMS, NLLB, Whisper) mediante ajuste fino, lo que reduce drásticamente los requisitos de datos y cómputo frente a entrenar desde cero. La factibilidad se analiza en sus dimensiones técnica, económica y operativa.

4.2 Factibilidad técnica

4.2.1. Hardware, cómputo e inferencia

El ajuste de modelos preentrenados puede realizarse en una estación con GPU y complementarse con créditos de GPU en la nube para las fases intensivas. La inferencia del *pipeline* integrado es ejecutable en equipo de gama media, compatible con un piloto en el punto de atención.

4.2.2. Estrategia de datos

El cuello de botella es el corpus clínico Quechua–Español, que se construirá de forma acotada (vocabulario y frases de triaje, síntomas e indicaciones) y se complementará

con recursos existentes (*Huqariq*, QuBERT) y datos sintéticos cuando sea pertinente.

4.2.3. Herramientas y software

Se emplearán bibliotecas de código abierto para habla y traducción (modelos MMS, NLLB y Whisper de Meta/OpenAI y sus ecosistemas), herramientas de evaluación (cálculo de WER, BLEU y chrF) y entornos reproducibles de *fine-tuning*.

4.3 Factibilidad económica

El presupuesto estimado (Cuadro 4) asciende a **S/ 7 350.00**, dominado por hardware con GPU y créditos de cómputo; es asumible en el marco de un trabajo de tesis y puede financiarse con recursos propios y/o apoyo institucional.

4.4 Factibilidad operativa

La validación con consultas simuladas y participantes voluntarios evita la dependencia de aprobaciones clínicas complejas y permite ejecutar los experimentos dentro del semestre, en un centro de salud de referencia en Cusco.

4.5 Viabilidad y sostenibilidad

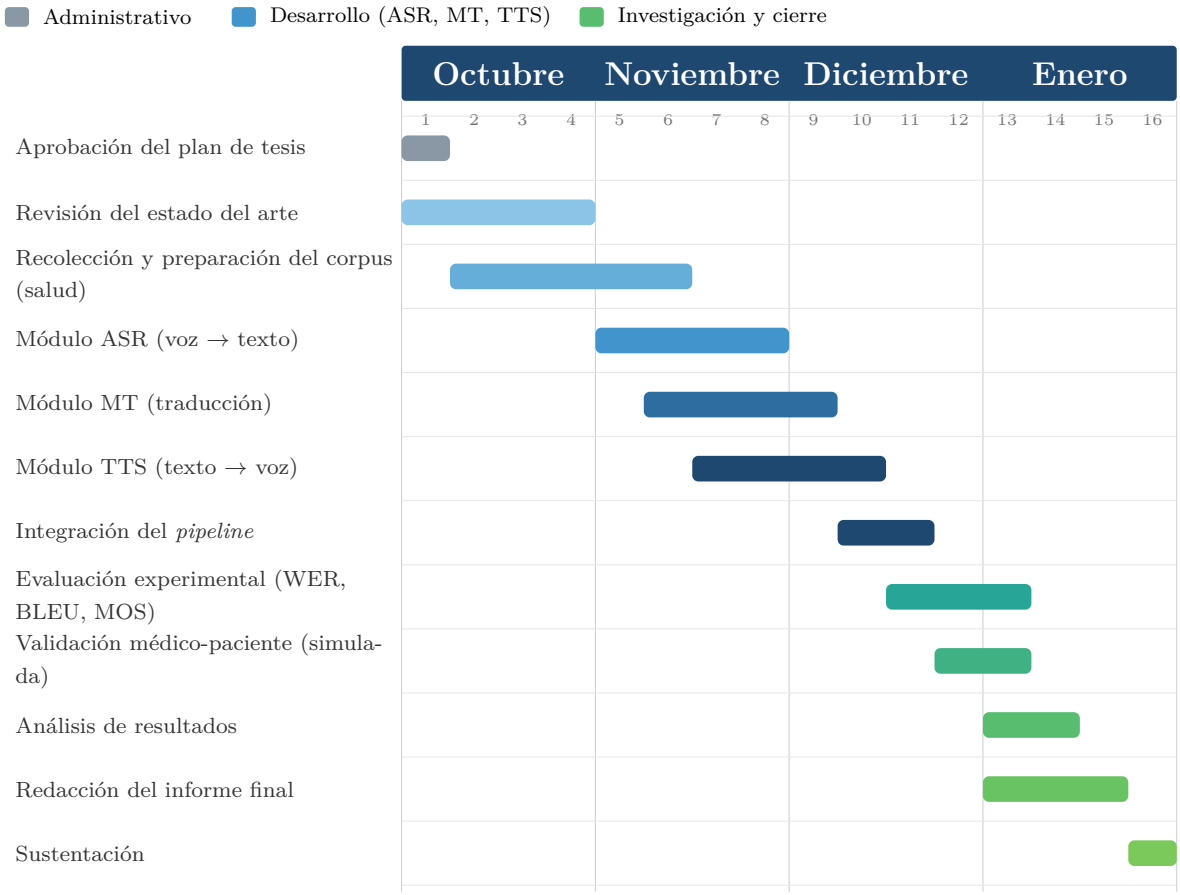
El proceso (corpus + ajuste + evaluación) es replicable en otras variantes del quechua o en otros dominios, y el uso de modelos de código abierto favorece la continuidad y la apropiación local de la tecnología.

V Aspectos administrativos

5.1 Cronograma de actividades

El proyecto se ejecuta en **4 meses (octubre 2026 – enero 2027)**, organizado por semanas. El Cuadro 3 presenta el diagrama de Gantt, con las actividades agrupadas en tres fases —*administrativa*, de *desarrollo* (ASR, MT y TTS) e *investigación y cierre*—; los módulos ASR, MT y TTS se ejecutan de forma parcialmente paralela mediante el ajuste de modelos preentrenados.

Tabla 3: Cronograma de actividades (octubre 2026 – enero 2027), por semanas.



5.2 Presupuesto y financiamiento

El Cuadro 4 resume los recursos estimados para el desarrollo del proyecto.

Tabla 4: Recursos para el desarrollo del proyecto de tesis (soles).

Tipo	**Descripción**	**Costo (S/)**
Hardware	Laptop/PC con GPU (entrenamiento y *fine-tuning*)	4 500.00
Cómputo	Créditos de GPU en la nube (horas de ajuste)	900.00
Datos	Grabación y validación del corpus clínico (incentivos a hablantes)	800.00
Administrativos	Impresiones, inscripción y trámites de tesis	600.00
Movilidad	Traslados al centro de salud y a comunidades	300.00
Otros	Gastos no previstos	250.00
Total		**7 350.00**

5.3 Equipo de investigación

El Cuadro 5 detalla el equipo responsable del proyecto.

Tabla 5: Equipo de investigación.

Rol	**Responsable / función**
Tesista	Alain Armando Condori Contreras —diseño, desarrollo y evaluación del sistema—.
Asesor	Mtro. Ing. Raúl Huillca Huallparimachi —orientación metodológica y técnica—.
Colaboradores	Personal de salud bilingüe (validación del corpus) y participantes voluntarios (consultas simuladas).

Referencias

Ahmed, N., Flechas Manrique, N., & Petrović, A. (2023). Enhancing Spanish-Quechua Machine Translation with Pre-Trained Models and Diverse Data Sources: LCT-EHU at AmericasNLP Shared Task. *Proceedings of the Workshop on NLP for Indigenous Languages of the Americas (AmericasNLP)*, 156-162. https://doi.org/10.18653/v1/2023.americasnlp-1.16

Alvarez-Crespo, A., Miranda-Salazar, D., & Ugarte, W. (2023). Model for Real-Time Subtitling from Spanish to Quechua Based on Cascade Speech Translation. *Proceedings of the International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART)*, *3*, 837-844. https://doi.org/10.5220/0011783300003393

Barbaran, B., & Ticona, W. (2026). Implementation of a Natural Language Processing Model for Spanish-Quechua Machine Translation. *Lecture Notes in Networks and Systems*, *1471*, 464-476. https://doi.org/10.1007/978-3-031-94770-4_37

Begazo Solís, C. L. (2026). *Barreras lingüísticas y culturales en la atención hospitalaria: la experiencia de pacientes quechua-hablantes* [Proyecto de investigación]. Universidad Peruana Cayetano Heredia [Repositorio institucional UPCH].

Chen, C.-C., Chen, W., Zevallos, R., & Ortega, J. E. (2024). Evaluating Self-Supervised Speech Representations for Indigenous American Languages. *Proceedings of LREC-COLING 2024*, 6444-6450.

Chen, W., & Fazio, B. (2021). Morphologically-Guided Segmentation for Translation of Agglutinative Low-Resource Languages. *Proceedings of the 4th Workshop on Technologies for Machine Translation of Low-Resource Languages (LoResMT)*, 20-31.

Cuaila, R. G. M. (2022). *Nivel de conocimiento del quechua y su relación con la calidad de atención del personal asistencial en servicios de salud de Huaylas, Áncash, 2022* [Tesis de licenciatura]. Universidad César Vallejo [Repositorio institucional UCV].

Cueva Medina, B., Tuco Casquino, G. F., & Sulla-Torres, J. (2024). Development of a Neural Machine Translation Model Optimized with BERT for Translation from Quechua to Spanish. *Proceedings of the LACCEI International Multiconference for Engineering, Education and Technology*. https://doi.org/10.18687/LACCEI2024.1.1.1636

Dhawan, A., Driggers-Ellis, C., Grant, C., & Wang, D. (2026). Improving Indigenous Language Machine Translation with Synthetic Data and Language-specific Preprocessing. *Proceedings of the 9th Workshop on Technologies for Machine Translation of Low Resource Languages (LoResMT)*, 119-126. https://doi.org/10.18653/v1/2026.loresmt-1.10

Ebrahimi, A., de Gibert, O., Vázquez, R., Coto-Solano, R., et al. (2024). Findings of the AmericasNLP 2024 Shared Task on Machine Translation into Indigenous Languages. *Proceedings of the 4th Workshop on NLP for Indigenous Languages of the Americas (AmericasNLP)*, 236-246. https://doi.org/10.18653/v1/2024.americasnlp-1.28

EsSalud. (2023, noviembre). *Presidenta de EsSalud reactiva central telefónica en quechua, en beneficio de 70 mil asegurados quechuahablantes del Cusco* [Nota de prensa]. Gob.pe. https://www.gob.pe/essalud

Fundación Dispurse. (2023). *Programas de alfabetización en Apurímac, Cajamarca y Cusco* [Nota de prensa]. Caretas.

Gow-Smith, E., & Sánchez Villegas, D. (2023). Sheffield's Submission to the AmericasNLP Shared Task on Machine Translation into Indigenous Languages. *Proceedings of the Workshop on NLP for Indigenous Languages of the Americas (AmericasNLP)*, 192-199.

Guzman, Y., Tavara, A., Zevallos, R., & Vega, H. (2021). Implementation of a Bilingual Participative Argumentation Web Platform for Collection of Spanish Text and Quechua Speech. *2021 International Conference on Electrical, Communication, and Computer Engineering (ICECCE)*, 1-6. https://doi.org/10.1109/ICECCE52056.2021.9514251

Huamán Curo, E., & Pineda Ancco, F. (2026). Quechua Speech Synthesizers. *Communications in Computer and Information Science, 2895*, 167-183. https://doi.org/10.1007/978-3-032-20322-9_12

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2017). *Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda, III de Comunidades Indígenas*. INEI. Lima, Perú.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2023, enero). *Día Internacional de la Educación: en Perú el 22.8 % de mujeres rurales no sabe leer ni escribir* [Nota de prensa]. INEI.

Mager, M., Oncevay, A., Ebrahimi, A., Ortega, J., Rios, A., Fan, A., Gutierrez-Vasques, X., Chiruzzo, L., Giménez-Lugo, G., Ramón, R., et al. (2021). Findings of the AmericasNLP 2021 shared task on open machine translation for Indigenous languages of the Americas. *Proceedings of the First Workshop on Natural Language Processing for Indigenous Languages of the Americas*, 202-217.

Moreno Véliz, O. (2021). The REPUcs' Spanish–Quechua Submission to the AmericasNLP 2021 Shared Task on Open Machine Translation. *Proceedings of the Workshop on NLP for Indigenous Languages of the Americas (AmericasNLP)*, 241-247.

NLLB Team. (2022). *No language left behind: Scaling human-centered machine translation* [Incluye el quechua de Ayacucho (quy); no la variante de Cusco (quz)]. arXiv: 2207.04672. https://arxiv.org/abs/2207.04672

Oncevay, A. (2021). Peru is Multilingual, Its Machine Translation Should Be Too? *Proceedings of the Workshop on NLP for Indigenous Languages of the Americas (AmericasNLP)*, 194-201. https://doi.org/10.18653/v1/2021.americasnlp-1.22

Ortega, J. E., Castro Mamani, R., & Cho, K. (2020). Neural machine translation with a polysynthetic low resource language. *Machine Translation*, *34*(4), 325-346.

Ortega, J. E., Zevallos, R., & Chen, W. (2023). QUESPA Submission for the IWSLT 2023 Dialect and Low-resource Speech Translation Tasks. *Proceedings of the 20th International Conference on Spoken Language Translation (IWSLT)*, 261-268.

Ortega, J. E., Zevallos, R., Chen, W., & Abdulmumin, I. (2025). QUESPA Submission for the IWSLT 2025 Dialectal and Low-resource Speech Translation Task. *Proceedings of the 22nd International Conference on Spoken Language Translation (IWSLT)*, 260-268. https://doi.org/10.18653/v1/2025.iwslt-1.25

Ortega, J. E., Zevallos, R., Chen, W., & Ahmad, I. S. (2024). QUESPA Submission for the IWSLT 2024 Dialectal and Low-resource Speech Translation Task. *Proceedings of the 21st International Conference on Spoken Language Translation (IWSLT)*, 173-181.

Papineni, K., Roukos, S., Ward, T., & Zhu, W.-J. (2002). BLEU: A method for automatic evaluation of machine translation. *Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 311-318.

Popović, M. (2015). chrF: Character n-gram F-score for automatic MT evaluation. *Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation (WMT)*, 392-395.

Pratap, V., Tjandra, A., Shi, B., Tomasello, P., Babu, A., Kundu, S., Elkahky, A., Ni, Z., Vyas, A., Fazel-Zarandi, M., Baevski, A., Adi, Y., Zhang, X., Hsu, W.-N., Conneau, A., & Auli, M. (2024). Scaling speech technology to 1,000+ languages. *Journal of Machine Learning Research*, *25*(97), 1-52.

Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2023). Robust speech recognition via large-scale weak supervision. *Proceedings of Machine Learning Research*, *202*, 28492-28518.

Zevallos, R., Bel, N., Cámbara, G., Farrús, M., & Luque, J. (2022). Data Augmentation for Low-Resource Quechua ASR Improvement. *Proc. Interspeech 2022*, 3518-3522. https://doi.org/10.21437/Interspeech.2022-770

Zevallos, R., Camacho, L., & Melgarejo, N. (2022). Huqariq: A multilingual speech corpus of native languages of Peru for speech recognition. *Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference (LREC)*, 5029-5034.

Zevallos, R., Cordova, J., & Camacho, L. (2020). Automatic Speech Recognition of Quechua Language Using HMM Toolkit. *Communications in Computer and Information Science*, *1070*, 61-68. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46140-9_6

Zevallos, R., Ortega, J. E., Chen, W., Castro, R., Bel, N., Yoshikawa, C., Ventura, R., Aradiel, H., & Melgarejo, N. (2022). Introducing QuBERT: A Large Monolingual Corpus and BERT Model for Southern Quechua. *Proceedings of the Third Workshop on Deep Learning for Low-Resource NLP (DeepLo)*, 1-13.

Anexos

Anexo 1: Matriz de consistencia lógica

Articula la coherencia interna entre el problema, los objetivos, las hipótesis y las variables.

Tabla 6: Matriz de consistencia lógica.

Problema	**Objetivo**	**Hipótesis**	**Variable/Indicador**
General: ¿De qué manera el sistema influye en la comunicación médico-paciente?	Desarrollar y evaluar el sistema de traducción bidireccional por voz.	El sistema mejora significativamente la comunicación médico-paciente.	Comprensión (% aciertos, Likert).
E1: ¿Qué corpus clínico se requiere?	Construir y validar el corpus Quechua–Español.	H1: el corpus validado aporta la base léxica para el ajuste.	Cobertura léxica, validación de contenido.
E2: ¿El ajuste mejora la precisión?	Adaptar NLLB al quechua de Cusco (`quz`) y MMS al dominio clínico.	H2: el ajuste reduce el WER y mejora el BLEU/chrF.	WER, BLEU/chrF.
E3: ¿Qué modalidad de salida es más comprensible?	Integrar la salida por voz y texto bidireccional para ambos interlocutores.	H3: texto+voz mejora la comprensión.	% aciertos, MOS.
E4: ¿Qué utilidad/confianza perciben los usuarios?	Validar en consulta simulada y medir percepción.	H4: mejora la comprensión mutua percibida.	Escala Likert, tiempo.

Anexo 2: Matriz de consistencia metodológica

Conecta cada objetivo específico con la variable que mide, la técnica e instrumento de recolección y el método de análisis previsto.

Tabla 7: Matriz de consistencia metodológica.

Objetivo específico	**Variable / indicador**	**Técnica e instrumento**	**Método de análisis**
OE1. Construir y validar el corpus clínico QU–ES.	Cobertura y validez del corpus (validación de contenido).	Fichas de validación revisadas con personal de salud bilingüe.	Juicio de expertos; % de concordancia.
OE2. Ajustar (*fine-tuning*) MMS y NLLB al dominio clínico.	Precisión de reconocimiento y traducción (WER, BLEU, chrF).	*Logs* automáticos del sistema por turno.	Estadística descriptiva; prueba t/Wilcoxon (ajustado vs. base).
OE3. Integrar el *pipeline* con salida por voz y texto.	Calidad de voz y comprensión (MOS, % aciertos).	Prueba de comprensión; valoración MOS.	Comparación texto vs. texto+voz.
OE4. Validar en consultas simuladas y medir percepción.	Utilidad, confianza y latencia (Likert, segundos).	Cuestionario Likert; cronómetro/*logs*.	Estadística descriptiva; pruebas de comparación.

Anexo 3: Ficha técnica de registro experimental

Plantilla para registrar cada *turno de traducción* durante las consultas simuladas.

Tabla 8: Ficha técnica de registro por turno (plantilla).

Campo	**Valor registrado**
ID de turno / sesión	_____
Escenario (triaje/síntomas/indicaciones)	_____
Dirección (`quz`→es / es→`quz`)	_____
Transcripción ASR / WER	_____
Traducción MT / BLEU / chrF	_____
Calidad de voz (MOS)	_____
Latencia por turno (s)	_____
Observaciones	_____

Anexo 4: Plantilla del banco de frases de consulta (evaluación)

Guión base de frases por escenario; el equivalente en quechua de Cusco se valida con hablantes nativos antes de su uso.

Tabla 9: Banco de frases de consulta simulada (ejemplos; `quz` por validar).

Categoría	**Enunciado (español)**	**Equivalente (quz)**
Triaje	¿Qué lo trae a la consulta?	[por validar]
Triaje	¿Hace cuánto tiempo se siente mal?	[por validar]
Síntomas	¿Dónde le duele?	[por validar]
Síntomas	¿Tiene fiebre o escalofríos?	[por validar]
Indicaciones	Tome esta pastilla cada 8 horas.	[por validar]
Indicaciones	Regrese en 3 días si no mejora.	[por validar]

Anexo 5: Cuestionario de percepción (escala Likert)

Escala de 1 (*totalmente en desacuerdo*) a 5 (*totalmente de acuerdo*); se aplica al personal y a los pacientes-actores.

Tabla 10: Ítems del cuestionario de percepción.

N.º	**Ítem**	**1–5**
1	El sistema facilitó la comunicación durante la consulta.	_____
2	Confío en la traducción que entregó el sistema.	_____
3	Comprendí con claridad las indicaciones médicas.	_____
4	La voz sintetizada fue clara y natural.	_____
5	El tiempo de respuesta del sistema fue adecuado.	_____
6	Usaría el sistema en una consulta real.	_____

Anexo 6: Modelo de consentimiento informado

Yo, _____, declaro haber sido informado(a) sobre los objetivos del estudio "Sistema bidireccional de traducción de voz Quechua–Español con IA preentrenada para consultas médicas en Cusco". Entiendo que participaré de forma voluntaria en consultas ***simuladas*** *—sin datos clínicos reales—, que las grabaciones serán anonimizadas y usadas solo con fines de investigación, y que puedo retirarme en cualquier momento sin perjuicio.*

_____ _____

Firma del participante Fecha